GRATIS-LERNHILFE · INTENSIVPFLEGE

Pflege beim intubierten Patienten

Tubus, Cuffdruck, VAP-Prophylaxe, Kommunikation und der Notfall-Check DOPES – kompakt für Examen und Station. Mit fertiger Musterpflegeplanung.

Bestehen ist planbar.

Tubus · Cuffdruck · VAP-Bündel · Kommunikation · DOPES · Pflegeplanung

20–30
cmH_2O Cuffdruck

30–45°
Oberkörper hoch

3
Pflegeprobleme

INHALT

1. Pflege im Überblick
2. VAP-Prophylaxe
3. Kommunikation
4. Notfall-Check DOPES
5. Komplikationen & Prüfungswissen
6. Musterpflegeplanung
7. Prüfungsfragen

⚠ Lernhilfe, ersetzt keine ärztliche Anordnung und keinen Hausstandard. Es gelten immer die Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

1 Pflege im Überblick

Ziel ist ein sicherer Atemweg ohne beatmungsassoziierte Pneumonie (VAP), Tubusdislokation, Druckschäden oder Delir.

Bereich	Worauf du achtest	Wie oft
Tubuslage	cm-Markierung an Zahnreihe/Mundwinkel mit Dokumentation vergleichen, seitengleiche Belüftung, Kapnografie-Kurve	jede Schicht, nach Lagerung und Transport
Fixierung	fest, aber ohne Druck; Beißschutz bei Unruhe; orale Lage nach Standard umlagern	jede Schicht
Cuffdruck	20–30 cmH_2O mit Cuffdruckmesser	mind. 1× pro Schicht und nach Umlagerung
Oberkörper	30–45° hochlagern, wenn nichts dagegen spricht	durchgehend
Mund und Zähne	Zähne putzen, Schleimhaut feucht halten, Lippen pflegen	mehrmals täglich nach Hausstandard
Absaugen	nach Bedarf, nicht nach Uhrzeit; subglottisch, wenn der Tubus es kann	bei Bedarf
Augen	Lidschluss prüfen, Hornhaut feucht halten und schützen	jede Schicht
Haut	Druckstellen an Lippe, Mundwinkel und an den Ohren (Bänder)	jede Schicht
Bewusstsein, Schmerz, Delir	RASS, BPS, CAM-ICU	mind. alle 8 Stunden

2 VAP-Prophylaxe

Das Bündel wirkt nur zusammen – jede Maßnahme jeden Tag.

- **Händehygiene** vor und nach jedem Kontakt
- **Oberkörper 30–45°**
- **Cuffdruck 20–30 cmH_2O**
- **Subglottische Sekretabsaugung**, wenn vorhanden
- **Mundpflege mit Zähneputzen** statt routinemäßiger Chlorhexidin-Spülung
- Täglich ärztlich prüfen: Sedierung reduzieren, Spontanatmung, Extubation möglich?
- **Kondenswasser** im Schlauch nie Richtung Patient laufen lassen
- Beatmungsschläuche **nicht routinemäßig** wechseln, nur bei Verschmutzung oder Defekt

3 Kommunikation

Intubierte können nicht sprechen, hören aber oft auch unter Sedierung mit.

- Jede Maßnahme vorher ankündigen
- Ja-Nein-Fragen stellen, Zeichen im Team weitergeben
- Buchstaben- oder Schreibtafel bereitlegen
- Klingel in Reichweite, Brille und Hörgerät anlegen
- Angehörige einbeziehen

4 Notfall-Check DOPES

Plötzliche Verschlechterung? Diese fünf Ursachen zuerst prüfen.

D	O	P	E	S
Dislokation des Tubus	Obstruktion: Sekret, Abknicken, Beißen	Pneumothorax	Equipment: Gerät, Schläuche, O_2	Stacking: Air-Trapping

Sofort Hilfe holen. Bei unklarer Ursache vom Respirator trennen und mit Beatmungsbeutel und 100 % Sauerstoff beatmen.

5 Komplikationen & Prüfungswissen

KOMPLIKATIONEN

- VAP
- Ungeplante Extubation
- Tubusobstruktion
- Druckschäden an Lippe und Trachea
- Stille Aspiration
- Delir
- Muskelabbau

DAS FRAGEN PRÜFER

- Cuffdruck 20–30 cmH_2O
- Oberkörper 30–45°
- Absaugen nach Bedarf
- Tubuslage über die cm-Markierung kontrollieren und dokumentieren
- Plötzliche Verschlechterung → DOPES

Tubus fest, Cuff im Ziel, Kopf hoch, Mund sauber – und jede Maßnahme ansagen.

6 Musterpflegeplanung

Nach PESR – immer an den einzelnen Menschen anpassen.

1 · Gefahr einer beatmungsassoziierten Pneumonie

Problem
Gefahr einer VAP infolge Endotrachealtubus, Sedierung und eingeschränktem Hustenstoß

Ressourcen
Kreislauf stabil, toleriert Oberkörperhochlage

Ziel
keine Zeichen einer Pneumonie bis zur Extubation (Temperatur, Sekret und Oxygenierung unverändert)

Maßnahmen
- Oberkörper 30–45° hochlagern
- Cuffdruck mind. 1× pro Schicht messen, Ziel 20–30 cmH_2O
- Zähne putzen und Mundpflege nach Hausstandard
- Absaugen nach Bedarf, subglottisch absaugen, wenn vorhanden
- Kondenswasser vom Patienten weg ableiten
- Sedierung und Extubationsbereitschaft täglich mit dem Arzt besprechen

Evaluation
jede Schicht Temperatur, Sekret (Menge, Farbe, Geruch), Auskultation und Beatmungswerte dokumentieren

2 · Beeinträchtigte verbale Kommunikation

Problem
kann sich nicht sprachlich mitteilen infolge Intubation, erkennbar an Unruhe, Gesten und Sprechversuchen

Ressourcen
wach (RASS 0 bis −1), kann nicken und mit Hilfe schreiben

Ziel
teilt innerhalb von 24 Stunden Schmerz, Durst und Lagerungswunsch über Ja-Nein-Zeichen oder Tafel mit

Maßnahmen
- Jede Maßnahme vorher ankündigen
- Ja-Nein-Zeichen vereinbaren und im Team weitergeben
- Buchstaben- oder Schreibtafel bereitlegen
- Klingel in Reichweite, Brille und Hörgerät anlegen
- Angehörige einbeziehen

Evaluation
jede Schicht prüfen, ob Bedürfnisse verstanden werden; Schmerz mit BPS erfassen

3 · Gefahr einer Hautschädigung durch Tubus und Fixierung

Problem
Gefahr eines Druckschadens an Lippe, Mundwinkel und Ohren infolge Tubus und Fixierband

Ressourcen
Haut und Schleimhaut aktuell intakt

Ziel
Haut und Schleimhaut bleiben bis zur Extubation intakt

Maßnahmen
- Fixierung jede Schicht auf Druck prüfen
- Orale Tubuslage nach Standard umlagern, dabei cm-Markierung kontrollieren
- Gefährdete Stellen polstern
- Lippen feucht halten und pflegen

Evaluation
jede Schicht Haut an Lippe, Mundwinkel und Ohren inspizieren und dokumentieren

7 Prüfungsfragen

Lösungen unten auf der Seite.

1. Welcher Cuffdruck wird angestrebt?

A) 5–10 cmH_2O | B) 20–30 cmH_2O | C) 40–50 cmH_2O | D) so hoch wie möglich

2. Wofür steht das P in DOPES?

A) Puls | B) Pupillen | C) Pneumothorax | D) PEEP

3. Wann wird ein intubierter Patient abgesaugt?

A) stündlich | B) einmal pro Schicht | C) nur vor der Visite | D) nach Bedarf

Lösungen: 1B · 2C · 3D

Mehr üben? In der PLAN-App findest du Prüfungsfragen zu Beatmung und Intensiv, Absaugen, Weaning und Sedierung – mit Erklärungen.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**